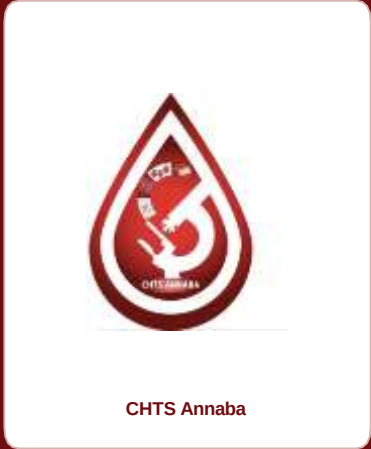




État des lieux des pratiques transfusionnelles au CHTS Annaba concernant la chaîne de préparation et de qualification des produits sanguins labiles chez le patient polytransfusé opéré

I. BABAY¹, M.H. BOULKADID¹, H. BROUK¹

¹ Centre d'Hémodiologie et de Transfusion Sanguine (CHTS), CHU Annaba — Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie



INTRODUCTION ET OBJECTIF

La sécurité des produits sanguins labiles (PSL) délivrés aux polytransfusés repose sur une chaîne technique complète, peu décrite dans les centres à ressources contraintes.

OBJECTIF

Décrire les pratiques de préparation, de qualification et de distribution des PSL au CHTS Annaba.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

- Étude prospective monocentrique (CHTS Annaba)
- 47 patients polytransfusés opérés : 36 drépanocytaires, 11 β -thalassémiques
- Recueil par épisode : PSL préparés et réservés, qualifications, compatibilité, protocole

FIGURE 1 — CHAÎNE DE PRÉPARATION ET DE QUALIFICATION, INTÉGRALEMENT RÉALISÉE AU CENTRE

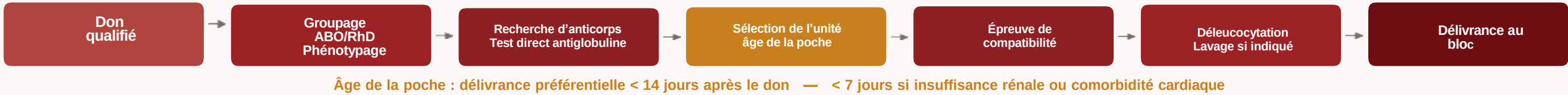


TABLEAU 1 — POPULATION (n = 47)

Drépanocytose	36 (76,6 %)
β -thalassémie	11 (23,4 %)
Sexe féminin	30 (63,8 %)
Âge médian (ans)	30 [19–67]
Transfusions antérieures	2 [0–10]
Comorbidité	18 (38,3 %)
Cholécystectomie	26 (55,3 %)
Splénectomie	13 (27,7 %)

TABLEAU 2 — PSL DÉLIVRÉS

Concentrés de globules rouges	250
Plasmas frais congelés	6
Concentrés plaquettaires	1
TOTAL PSL délivrés	295
CGR maintenus en réserve	52
CGR / patient – médiane	6 [1–16]
drépanocytose / β -thalassémie	6 / 4

FIGURE 2 — QUALIFICATIONS APPLIQUÉES AUX CGR

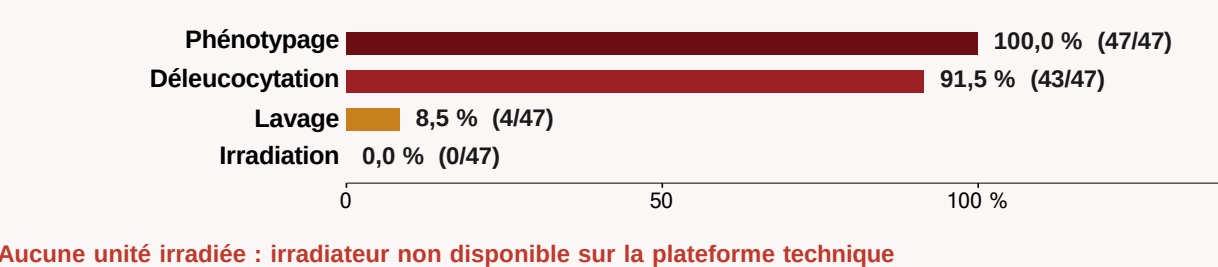


FIGURE 3 — TECHNIQUE DE COMPATIBILITÉ

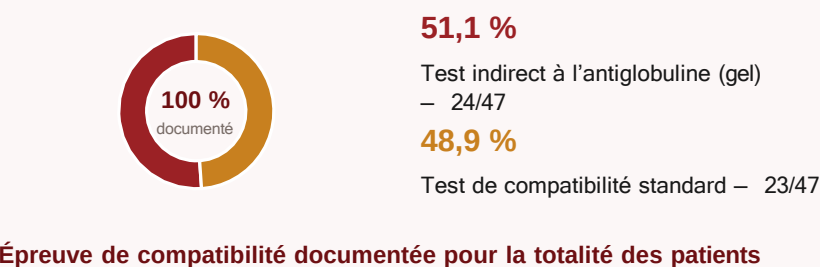


FIGURE 4 — PROTOCOLE TRANSFUSIONNEL SELON LA PATHOLOGIE

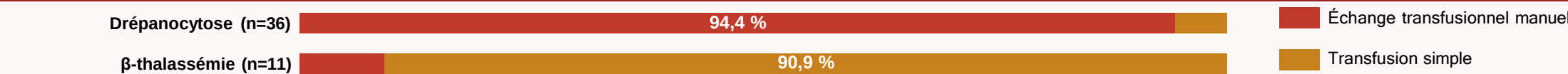
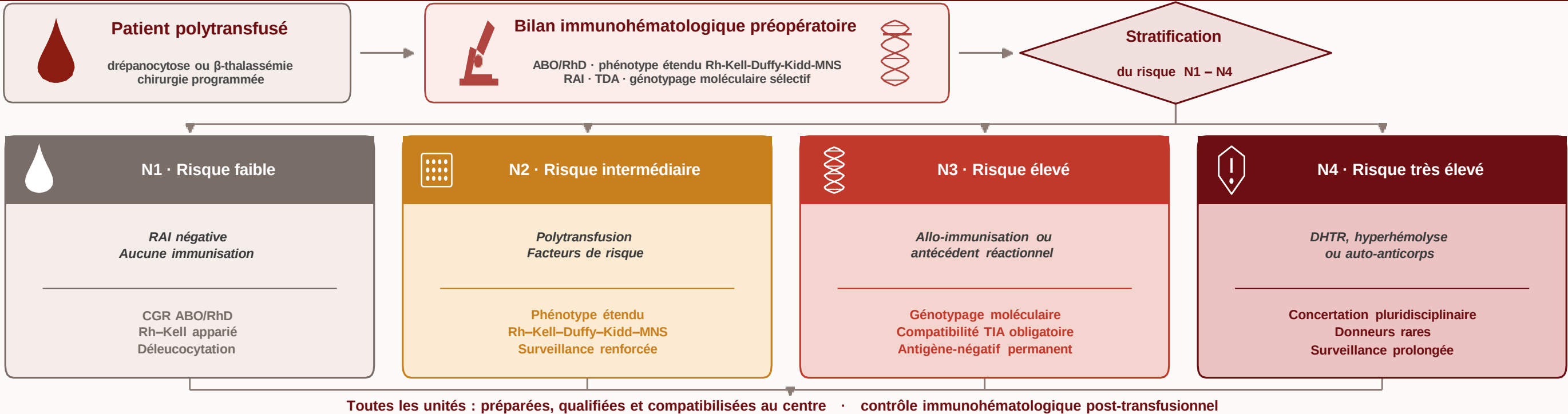


FIGURE 5 — ALGORITHME DÉCISIONNEL DU CENTRE : DU BILAN IMMUNOHÉMATOLOGIQUE À LA PRÉPARATION INDIVIDUALISÉE



CONCLUSION

- Chaîne de préparation et de qualification assurée intégralement en interne : 295 PSL délivrés, dont 250 CGR tous phénotypés, 91,5 % déleucocytés, compatibilité documentée chez 100 % des patients.
- Un algorithme décisionnel à quatre niveaux (N1-N4) gradue l'appariement selon le profil immunohématologique : une médecine transfusionnelle de précision transposable à d'autres centres.

RÉFÉRENCES

1. Cancelas JA. Precision transfusion medicine: a new spin. Blood. 2022;140(15):1661-1663.
2. Chou ST, Alsawas M, Fasano RM, et al. ASH 2020 guidelines for sickle cell disease: transfusion support. Blood Adv. 2020;4(2):327-355.
3. Floch A, Viret S, Malard L, et al. Eleven years of alloimmunization in 6496 patients with sickle cell disease in France. Blood Adv. 2023;7(24):7608-7620.
4. Al-Allawi N, Al-Mousawi MM, Al-Allawi S, Ibrahim KJ. Alloimmunization in β -thalassaemia and sickle cell disease in Middle Eastern countries. Hemoglobin. 2025;49(2):126-140.
5. Al Mozain N, Ellobied Y, Al-Omran A, et al. Chronic automated red blood cell exchange versus manual exchange in sickle cell disease. Asian J Transfus Sci. 2023;17(1):91-96.
6. Israelyan N, Vege S, Friedman DF, et al. RH genotypes and red cell alloimmunization rates in chronically transfused patients with sickle cell disease. Transfusion. 2024;64(3):526-535.